

AAMIA · RESUMEN TEMÁTICO 5 DE 5

# Memoria, bienestar y relaciones humanas

Cognición, comunicación, ánimo, vínculos, espiritualidad, dignidad y redes

memoria

atención

estimulación cognitiva

Audiencia: Personas mayores, familias, cuidadores y equipos comunitarios

## Uso responsable

Este documento organiza y resume una biblioteca local. No diagnostica, no prescribe y no sustituye una valoración profesional. Las fuentes originales son la evidencia canónica; las referencias usan la página física del PDF.

Edición 1.0 · Julio de 2026 · Proyecto AAMIA

## Cómo usar este resumen

Está diseñado para recuperación aumentada: cada apartado concentra una intención de búsqueda y conserva referencias legibles. Para decisiones importantes se consulta la fuente original y al equipo profesional.

| Campo                 | Valor                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tema principal        | Memoria, bienestar y relaciones humanas                                                               |
| Temas de recuperación | memoria, atención, estimulación cognitiva, depresión, comunicación, familia, espiritualidad, dignidad |
| Tipo de fuente        | Resumen secundario; remite a evidencia original                                                       |
| Riesgo clínico        | Mixto: educativo con señales de consulta y urgencia                                                   |
| Contexto Markdown     | Usado para redactar; no es documento indexado                                                         |

## Principios de síntesis

- La persona conserva identidad, historia y derechos aunque cambien memoria o función.
- La estimulación útil tiene significado, elección y conexión; no es un examen permanente.
- Depresión, aislamiento y pérdida funcional se influyen entre sí y son tratables.
- La espiritualidad se incorpora solo según creencias y preferencias de la persona.

### Jerarquía de uso

1) localizar el tema; 2) recuperar los fragmentos originales; 3) responder indicando documento y página; 4) reconocer cuando la biblioteca no basta.

## 1. Cambios de memoria: observar el impacto

Un olvido aislado no equivale a demencia. Preocupa más el cambio progresivo que interfiere con tareas o el cambio súbito.

- Observar dificultad nueva para manejar dinero, medicamentos, rutas, conversaciones, cocina o citas.
- Registrar inicio, frecuencia, ejemplos y relación con sueño, dolor, ánimo, infección o medicamentos.
- Consultar ante deterioro progresivo o preocupación de la persona o familia.
- Confusión súbita, somnolencia inusual o fluctuación marcada requieren valoración pronta.

Diferenciación y planificación en [R1, pp. 2 y 7], [R4, pp. 47 y 92] y el contexto editorial.

## 2. Estimulación cognitiva con propósito

Las actividades se ajustan a intereses y capacidad para evitar frustración.

- Usar conversación sobre historia personal, música, lectura, fotografías, listas, juegos o tareas conocidas.
- Combinar memoria, atención, lenguaje, percepción y movimiento en sesiones breves.
- Reducir distractores, presentar una tarea a la vez y aumentar dificultad solo si sigue siendo positiva.
- Conservar actividades sociales y diarias; practicar no significa corregir cada error.

Atención y ejercicios en [R2, pp. 16 y 28]; estimulación múltiple en [R3, pp. 39-40 y 47].

## 3. Comunicación respetuosa

La forma de hablar puede reducir ansiedad y facilitar participación.

- Acercarse de frente, presentarse si hace falta, usar frases claras y dar tiempo para responder.
- Ofrecer una instrucción por vez y apoyar con gestos sin usar tono infantil.
- Validar la emoción aunque el recuerdo sea impreciso; evitar discutir solo para demostrar quién tiene razón.
- Revisar audición, visión, dolor, hambre, baño y ambiente antes de llamar oposición a una conducta.

Comunicación y empatía en [R1, p. 7], [R13, p. 101] y manuales citados en los resúmenes 1 y 2.

## 4. Ánimo, depresión y participación

La depresión no es una consecuencia normal de envejecer y puede verse como irritabilidad, aislamiento, menor interés o pérdida funcional.

- Observar tristeza persistente, ansiedad, cansancio, desesperanza y cambios de sueño o apetito.
- Mantener contacto, movimiento y actividades significativas sin exigir que la persona se anime.
- Solicitar valoración; dolor, medicamentos, enfermedad y pérdidas recientes pueden contribuir.
- Ante ideas de muerte o autolesión, no dejar sola a la persona y buscar ayuda urgente.

Relación entre depresión y función en [R5, pp. 2, 5 y 7-8]; ánimo en [R4, pp. 40 y 193].

## 5. Propósito, participación y vínculos

Bienestar incluye agencia, relaciones y actividades valiosas dentro de las posibilidades actuales.

- Preguntar qué desea conservar, aprender, enseñar o compartir.
- Favorecer grupos, voluntariado, cultura, contacto intergeneracional y tareas con propósito.
- Hablar de expectativas, tareas, dinero, decisiones médicas y descansos antes de una crisis familiar.
- Reconocer que algunos cuidadores también son mayores y necesitan apoyos propios.

Participación en [R4, pp. 11 y 31], vínculos en [R7, p. 107] y cuidado intergeneracional en [R8, pp. 1, 3 y 5].

## 6. Espiritualidad sin imposición

La espiritualidad puede relacionarse con sentido, esperanza, conexión, religión o valores no religiosos.

- Preguntar si desea incorporar alguna creencia, práctica, comunidad o persona al cuidado.
- Facilitar privacidad, objetos, música o contacto comunitario cuando lo solicite.
- No interpretar sufrimiento solo como problema espiritual ni sustituir atención clínica.
- Respetar también el deseo de no participar en prácticas religiosas.

Cuidado espiritual y límites conceptuales en [R6, pp. 5-6].

## 7. Dignidad y decisiones difíciles

La capacidad puede ser específica para cada decisión y no desaparece por edad o diagnóstico.

- Explicar opciones de manera comprensible y apoyar participación máxima.
- Conocer valores, prioridades y voluntades anticipadas antes de una crisis.
- En demencia avanzada, decisiones clínicas requieren evaluación, representación válida y consideración de deseos previos.
- Restricción, institucionalización o manejo de finanzas exige salvaguardas y revisión.

Dignidad en [R9, p. 6] y decisiones en [R12, pp. 1 y 3-4]; enfoque integral en [R13, p. 128].

## Orientación por nivel de acción

Esta tabla no es un sistema de triaje. Resume una respuesta conservadora a cambios comunes y señales de peligro.

| Nivel            | Situación                                                                                                     | Acción                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Acompañar        | Olvidos ocasionales sin pérdida de función, tristeza transitoria o necesidad de más tiempo.                   | Adaptar ambiente, mantener participación y observar cambios.  |
| Consultar        | Deterioro progresivo, aislamiento, pérdida de interés, alucinaciones nuevas o dificultad en tareas conocidas. | Solicitar valoración con ejemplos, cronología y medicamentos. |
| Atención urgente | Confusión súbita, riesgo de autolesión, violencia, incapacidad para estar a salvo o deterioro rápido.         | Permanecer, reducir riesgos y contactar emergencias o crisis. |

### Regla de seguridad

Cuando el cambio es súbito, intenso, empeora rápido o la persona no puede mantenerse a salvo, se prioriza ayuda humana inmediata sobre la consulta al RAG.

## Qué debe conservar una respuesta de AAMIA

- Diferenciar educación general de indicaciones personalizadas.
- Mostrar fuentes originales y páginas que sostienen la respuesta.
- Declarar incertidumbre, antigüedad o desacuerdo entre fuentes.
- No transformar procedimientos clínicos en instrucciones domésticas.
- Recordar que autonomía, preferencias y contexto importan.

# Fuentes utilizadas

Las páginas son páginas físicas del PDF. Las referencias documentan conceptos centrales; no implican adoptar toda afirmación de la fuente.

## Criterio editorial

Se priorizaron recomendaciones convergentes, prudentes y aplicables. Las fuentes antiguas o especializadas se conservaron como contexto cuando requerían corroboración actual.

### [R1] AAMIA\_guia\_abierta\_para\_el\_cuidado.pdf

Páginas PDF: 2, 7. Tipo: Guía abierta.

### [R2] Cómo mejorar la memoria y la atención en estudiantes y adultos mayores (Fau, Mauricio Enrique).pdf

Páginas PDF: 16, 22, 28. Tipo: Guía práctica.

### [R3] Estimulación múltiple en adultos mayores estrategias (Arévalo Herrera, Diana M.).pdf

Páginas PDF: 39-40, 47. Tipo: Manual de intervención.

### [R4] Envejecer con alegría guía para acompañar y vivir la tercera edad (Montoya Carrasquilla, Jorge).pdf

Páginas PDF: 11, 31, 40, 47, 92, 102-105, 183, 193. Tipo: Libro de consulta.

### [R5] Comprendiendo el impacto de los síntomas depresivos en la funcionalidad de las personas mayores.pdf

Páginas PDF: 2, 5, 7-8. Tipo: Revisión clínica, 2017.

### [R6] 13-cuidado\_espiritual.pdf

Páginas PDF: 5-6. Tipo: Artículo de reflexión, 2020.

### [R7] Salud, familias y vínculos en el mundo de los adultos mayores (Elsa López López, Elsa).pdf

Páginas PDF: 107. Tipo: Libro académico.

### [R8] Hijos-adultos-mayores-al-cuidado-de-sus-padres--\_2012\_Revista-M-dica-CI-nica.pdf

Páginas PDF: 1, 3, 5. Tipo: Artículo psicosocial, 2012.

### [R9] Reflexiones-sobre-calidad-de-vida--dignidad-y-\_2012\_Revista-M-dica-CI-nica-L.pdf

Páginas PDF: 6. Tipo: Revisión ética, 2012.

### [R10] El-viejo-y-su-tiempo--Hacia-una--tica-de-la-r\_2012\_Revista-M-dica-CI-nica-La.pdf

Páginas PDF: 1-5. Tipo: Ensayo ético, 2012.

### [R11] Una-visi-n-optimista-del-envejecimient\_2012\_Revista-M-dica-CI-nica-Las-Conde.pdf

Páginas PDF: 1-2. Tipo: Ensayo, 2012.

### [R12] Toma-de-decisiones-en-pacientes-con-demencia\_2012\_Revista-M-dica-CI-nica-Las.pdf

Páginas PDF: 1, 3-4. Tipo: Revisión clínica y ética, 2012.

### [R13] Viviendo la tercera edad un modelo integral de consejería para el buen envejecimiento (Montilla R., Esteban).pdf

Páginas PDF: 101, 128. Tipo: Libro de consejería.

### [R14] Notas--Hombres-en-peligro-\_2012\_Revista-M-dica-CI-nica-Las-Condes.pdf

Páginas PDF: 1-2. Tipo: Nota demográfica, 2012. Nota: Contexto de género.

## Contexto editorial no indexado

Estos Markdown ayudaron a contrastar lenguaje y necesidades domésticas. No se incorporan al índice ni a la carga pública.

- Artículo web- Cuidado de adultos mayores en casa- Una guía integral.md (compañía, red y agotamiento; no indexado).
- Artículo web- Qué cuidados debo brindar a un adulto mayor.md (participación social; no indexado).
- Transcripción video de YouTube - Cuidado básico del adulto mayor webinar.md (memoria, autonomía, roles y enfoque integral; no indexado).

## Archivos revisados y no usados como evidencia

- Mujer-anciana-de-Arles--Vincent-van-gogh--19\_2012\_Revista-M-dica-CI-nica-Las.pdf: comentario de portada sin evidencia para recomendaciones.